

Einführung

Den meisten pflegebedürftig gewordenen Menschen und deren Angehörigen ist der Entschluss, einen Pflegedienst zu beanspruchen, nicht leichtgefallen. Für den Betroffenen ist es ein einschneidendes Erlebnis, oft verbunden mit Ängsten vor dem Verlust der Unabhängigkeit. Wir wollen erreichen, dass die Umstellung nicht als zu belastend und die Eingewöhnung in den Alltag so leicht wie möglich erlebt wird. Dabei ist zu beachten, dass der Patient auch das Recht hat, sich zurückzuziehen. Maxime unseres Handelns ist das Vermitteln von Sicherheit, Geborgenheit und Wohlbefinden.

Der Patient sollte gleich nach dem erfolgten Einzug unter Berücksichtigung seiner Wünsche und Bedürfnisse schrittweise in das soziale Gefüge des Pflegedienstes integriert werden, um der Gefahr eines sozialen Rückzugs vorzubeugen. Ihm ist das Gefühl zu vermitteln, dass er in der Intensivpflege Halle GmbH willkommen ist und dass die Entscheidung für den Umzug richtig war. Ängste, Befürchtungen und Bedenken eines Patienten und seiner Angehörigen, auch wenn sie irrational wirken, werden von den Pflegekräften ernst genommen. Bestehen Aggressionen, Wut und Ärger über den Umzug, so werden diese Emotionen von den Pflegekräften akzeptiert.

Für den reibungslosen Ablauf des Einzuges und für die Begleitung in der Eingewöhnungsphase ist die Bezugspflegefachkraft verantwortlich. In den ersten Wochen nach dem Einzug nimmt sie sich Zeit für den neuen Patienten. Zwischen Patient und den Mitarbeitern soll von Anfang an ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und entwickelt werden.

Die Bezugspflegefachkraft ist verantwortlich für die Förderung des Wohlbefindens, des Sicherheitsgefühls der versorgten Person und der Integration in die neue Lebensumgebung. Ebenfalls eingeschlossen ist die zeitgerechte Vorbereitung der bedarfs- und bedürfnisgerechten Versorgung

1. Erstkontakt

Der Erstkontakt findet in der Regel über das Telefon, z.B. zwecks Terminvereinbarung, oder durch einen spontanen Besuch in der Einrichtung statt und wird in erster Linie von Angehörigen vorgenommen. Erstkontakte finden aber auch zwischen gesetzlichen Betreuern sowie Mitarbeitern von Sozialstationen und dem Personal der Einrichtung statt. Der Erstkontakt wird dokumentiert.

Je nach Interessenslage des Anrufers bzw. Besuchers erhält dieser die von ihm erwünschten Informationen (z.B. über einen freien Platz oder zu den Kosten), einen Gesprächstermin, die Vermittlung an einen geeigneten Gesprächspartner oder die Zusage für die Zusendung von Informationsmaterial.

2. Beratungsgespräch zur Aufnahme

Das Beratungsgespräch ist in der Regel inhaltlich vom pflegerischen Erstgespräch (siehe Punkt 3) klar abgegrenzt, kann aber, wenn möglich (z.B. bei Anwesenheit des zukünftigen Patient) in das Erstgespräch integriert werden.

2.1 Ziele des Beratungsgespräches

- Wünsche des Kunden erkennen
- Informationen zu Angeboten, Leistungen, Kosten etc. erteilen
- Vertrauen aufbauen, Ängste nehmen, Akzeptanz herstellen
- Eindruck vom Wohnen in der Einrichtung verschaffen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1/4	Verw./MA

2.2 Inhaltliche Schwerpunkte

Das Beratungsgespräch beinhaltet unter anderem folgende Informationen und Klärung:

- Erwartungen und Vorstellungen erfragen
- ggf. auf Wartezeiten und Einzelzimmer hinweisen
- Konzeption und Serviceangebot erläutern
- Information über ärztliche und therapeutische Versorgung
- Kosten und Leistungsangebote
- Mitbringen von eigenen, ganz privaten Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (z.B. Kleinmöbel, Bilder, Lampen)
- Mitbringen von Haustieren nach Absprache
- Wäschebedarf und Wäschekennzeichnung, Servicewünsche (Reinigung)
- Kostenerschließende Beratung zu Kosten, zum Leistungsanspruch nach § 43 SGB XI und § 61 SGB XII und zur Finanzierung des Eigenanteils
- Legitimierten Vertragspartner und Rechnungsempfänger feststellen, ggf. über Vollmachtserteilung oder gerichtliche Betreuung informieren
- Informationen zum Eigenanteil und Lastschrifteneinzugsermächtigung
- Erforderliche Unterlagen zur Aufnahme benennen: MDK-Empfehlung zum Pflegegrad, ärztliches Gutachten, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, Zuzahlungsbefreiung, Schwerbehindertenausweis, Nachweis über gerichtliche Betreuung oder deren Einleitung/ Betreuerausweis, Vorsorgevollmacht
- Aktuellen medizinisch-pflegerischen Zustand erfragen
- Vorhandensein einer Patientenverfügung
- Abschluss einer Bestattungsvorsorge erfragen

Nach dem Gespräch erfolgt die Besichtigung des Hauses und des Zimmers. Ein Termin bezüglich des voraussichtlichen Einzugs oder zwecks weiterer Rücksprachen wird vereinbart.

3. Pflegerisches Erstgespräch

Ist die Entscheidung gefallen, dass ein Einzug in die Intensivpflege Halle GmbH erfolgen soll, findet ein pflegerisches Erstgespräch durch die PDL /PFK statt. Beim pflegerischen Erstgespräch werden Wünsche, Bedürfnisse, biographische Angaben und der Pflegebedarf vorab ermittelt um den Umzug in die Einrichtung so angenehm wie möglich zu gestalten. Der zukünftige Patient wird über mitzubringende Kleidung (z.B. rutschfestes Schuhwerk bei Sturzgefährdung usw.) informiert. Es wird nochmal betont, dass das Mitbringen von persönlichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen zur Schaffung eines wohnlich gestalteten Umfelds ausdrücklich erwünscht ist.

4. Vorbereitung des Einzugs

Die PDL informiert rechtzeitig den entsprechenden Teams über den Termin des Einzugs des zukünftigen Patienten

4.1. Vorbereitung des Patientenumfeldes

- Grundreinigung des Zimmers
- Reparaturen bzw. Veränderungen/ Umstellungen im Zimmer, die mit dem zukünftigen Patienten vereinbart wurden
- Zimmer herrichten (z.B. Bett, Rufanlage, Getränke, Blumen, Nachttisch, Handtücher, Telefon, evtl. Lagerungshilfen)

4.2 Administrative und pflegerische Vorbereitung vor dem Einzug

Administrative Vorbereitung- Leitungspersonal	Pflegerische Vorbereitung- Pflegepersonal
• Anlegen der Hauptakte für die Verwaltung • Checkliste Einzug neuer Patient Verwaltung bereitlegen • Erstellen des Vertrages und der Anhänge, wenn möglich Abschluss • Unterlagen zur Versorgung • MDK-Empfehlung zum Pflegegrad • ärztliches Gutachten, dass der zukünftige Patient keine ansteckende Lungentuberkulose hat (§36 IfSG) • Personalausweis • Krankenversicherungskarte • Zuzahlungsbefreiung • Schwerbehindertenausweis • Nachweis über gerichtliche Betreuung oder deren Einleitung/ Betreuerausweis • Vorsorgevollmacht • Patientenverfügung/ Testament • Bestattungswünsche	• Anlegen der kompletten Pflegedokumentation • Stammdaten und erste Informationen über den Patienten eintragen • Einfuhrpläne bereitlegen (7 Tage führen) • Schmerzprotokoll bereitlegen (7 Tage führen) • Checkliste Einzug neuer Bewohner bereitlegen • ggf. Hilfsmittel im Vorfeld organisieren, wie Inkontinenzmaterial, ADM, Ernährungspumpe über Lieferanten

4.2.1 Administrative und pflegerische Aufgaben nach Einzug des Bewohners

Administrative Vorbereitung- Leitungspersonal	Pflegerische Vorbereitung- Pflegepersonal
• ggf. Abschluss Vertrag • Aufnahmeanzeige an Kostenträger, Sozialhilfeträger • Bei Zuzahlungsbefreiung Information an Apotheke, Lieferanten, Ärzte	• Information über Einzug an behandelnde Ärzte (per Fax der mitgebrachten Arztbriefe), Apotheke • Information an Lieferanten, wenn notwendig • Komplettes Risikomanagement innerhalb von 24 Stunden erstmalig ausfüllen • Einfuhrplan führen für 7 Tage • Schmerzprotokoll führen für 7 Tage • Erfassen der Vitalzeichen, wie RR,P, Temperatur, Körpergröße, Gewicht, BMI innerhalb der ersten 24 Stunden • Checkliste Einzug neuer Bewohner ausfüllen, verantwortlich sind alle Pflegekräfte Pflegedokumentation entsprechend des Pflegeprozesses: • Anamnese/SIS nach Einzug, Risikorelevante Bereiche planen → innerhalb 24 Stunden • Stammbblatt ergänzen, Hilfsmittel eintragen, Zuzahlungsbefreiung, Patientenverfügung, Vollmachten, Bestattungswunsch usw. dokumentieren • Adresse: Krankenkasse und Versicherungsnummer eintragen • Angehörige, behandelnde Ärzte mit Telefonnummer, ggf. Anschrift notieren

In der Regel kommt der Patient direkt im Team an.

Alle erforderlichen Daten und Unterlagen, die im Vorfeld nicht bekannt oder überreicht worden sind, werden im Laufe der folgenden Tage von den jeweils zuständigen Mitarbeitern eingeholt.

5. Begrüßung

Für die Begrüßung des Patienten und dessen Angehörige/ Betreuer wird ausreichend Zeit eingeplant. Es wird ihm Hilfe beim Auspacken/ Einräumen angeboten, persönliche Einrichtungsgegenstände werden aufgestellt.

Nachstehendes erfolgt stets unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes des Patienten.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN MIT LICHT UND FARBEN	Verfahren Einzug neuer Bewohner/ Patient	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

5.1 Personal, Mitbewohner

In den ersten Tagen steht neben der Pflege die psycho-soziale Betreuung durch das Pflegepersonal Vordergrund. Es findet eine umfassende Information über die Intensivpflege Halle GmbH, Mitarbeiter, Bezugspflege und Abläufe statt, wobei der neue Patient nicht mit zu vielen Eindrücken überfordert und sichergestellt ist, dass die Information auch verstanden wird.

5.2 Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten werden gezeigt (z.B. Bad, Toiletten, Diensträume, Fahrstühle), Kommunikationshilfen (Briefkasten, Info-Tafeln) und die Funktion des Notrufs erläutert und erklärt.

5.3 Abläufe, Service

Abläufe, wie Essenszeiten, Dienstzeiten, Sprechstunden, Zimmerreinigung, Wäschereinigung werden erklärt.

5.4 Wünsche/ Versorgungsbedarf/ Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Ergänzend zu den bisherigen Informationen erfragt und dokumentiert die Bezugspflegefachkraft:

- Besondere Wünsche im Krankheitsfall
- Serviceangebote bezüglich Friseurs, Maniküre, Pediküre
- Gewohnheiten wie Schlafenszeiten, Hygienemaßnahmen (Baden, Duschen), Trink- und Essgewohnheiten bzw. Vorlieben und Abneigungen bei Speisen und Getränken

6. Eingewöhnung in den Folgetagen

In der Eingewöhnungsphase stehen die Erreichung von Zufriedenheit, Wohlbefinden und Geborgenheit und das Vermitteln von Sicherheit im Vordergrund. Es wird überprüft, ob der Patient die Funktionsweise und Bedienung der wichtigen Geräte, insbesondere die Notrufanlage, verstanden hat und sich zurechtfindet. Angehörige und Bezugspersonen werden so weit wie möglich in den Pflegeprozess einbezogen. Die Informationssammlung zu allen Lebensbereichen sowie die Pflegeprozessplanung und die Vervollständigung aller notwendigen Daten findet fortlaufend statt.

Weitere Hilfe erfolgt bei der Einrichtung und dem Anbringen/ Aufstellen persönlicher Gegenstände und der individuellen, wohnlichen Gestaltung des Umfeldes (dazu gehört auch das Anbringen von persönlichen Orientierungshilfen je nach Bedarf), beim Umgang mit Hilfsmitteln und technischen Geräten sowie der Orientierung in der Einrichtung. Das Erfragen von weiterem Unterstützungsbedarf, z.B. bei behördlichen Angelegenheiten, ist sicherzustellen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	5/4	Verw./MA